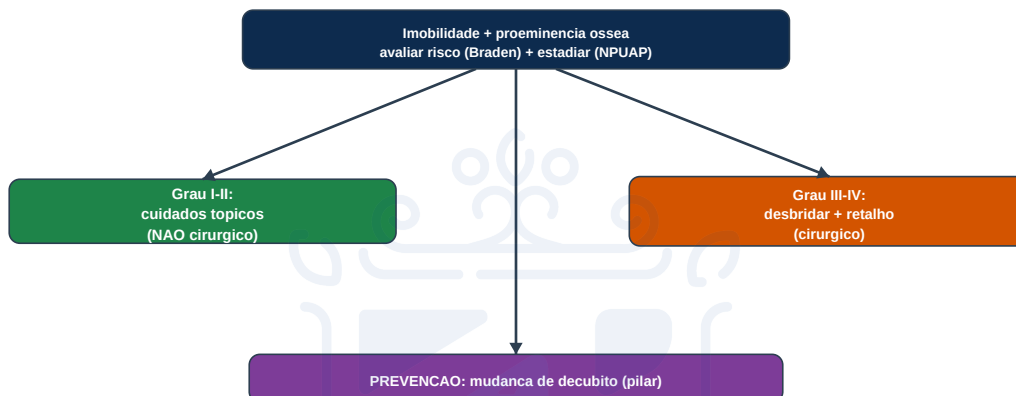


LESÃO POR PRESSÃO — PREVENIR + ESTADIAR

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

LESÃO POR PRESSÃO — ESTADIAR -> CONDUTA



DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA

O QUE É

- Lesão de pele/tecidos sobre PROEMINÊNCIA ÓSSEA por pressão ($\pm$ cisalhamento) prolongada; etiologia multifatorial (local e sistêmica)
- Principal fator de risco: IMOBILIDADE (idosos, fraturas de MMII, doenças neurológicas)
- Fisiopatologia: pressão de fechamento capilar ~ 32 mmHg; lesão ocorre com pressão $> \sim 50$ mmHg por > 2 h
- Locais típicos: sacro, ísquio, trocânter, calcâneo
- Avaliação de risco com a escala de BRADEN (percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção/cisalhamento)

CLASSIFICAÇÃO (NPUAP)

Grau	Achado
Grau I	Epiderme INTACTA, eritema fixo (não embranquece)
Grau II	Perda de epiderme + derme (úlceras superficiais/flictenas)
Grau III	Atinge subcutâneo, SEM exposição de estruturas profundas
Grau IV	Atinge subcutâneo COM exposição de osso/tendão/músculo
Não classificável / tissular profunda	Escara/esfacelo cobrindo o fundo; ou pele íntegra com descoloração (lesão tissular profunda)

PREVENÇÃO (PILAR) E TRATAMENTO CLÍNICO

Rx GRAUS I-II — NÃO CIRÚRGICO

PREVENÇÃO é o principal: MUDANÇA REGULAR DE DECÚBITO + dispositivos de alívio de pressão
Avaliação de risco (Braden), equipe multidisciplinar, controle de comorbidades, suporte nutricional
Cuidados com a pele: hidratação, produtos de barreira, controle de incontinência/umidade
Curativos tópicos (graus I-III): AGE/Dersani — limpar com SF, aplicar e ocluir, trocar a cada 12h
Desbridante enzimático: Papaína (2-10%) — limpar com SF, aplicar, ocluir, trocar a cada 12h

TRATAMENTO CIRÚRGICO (GRAUS III-IV)

DESRIDAMENTO + RETALHO

- Indicação: graus III e IV; excisão em bloco da bursa, retirada de espículas ósseas, preenchimento do espaço morto com retalhos fasciocutâneos/miocutâneos
- Otimização clínica pré-operatória: Hb > 10 g/dL e albumina > 3,5 g/dL
- Suspeita de OSTEOMIELEITE: reconstrução em 2 tempos (biópsia/cultura óssea + avaliação ortopédica); baixo risco -> tempo único
- Retalhos por local: sacral (V-Y, rotação/transposição), trocantérico (tensor da fáscia lata), isquiático (avanço posterior da coxa)
- Complicações: necrose do retalho, recidiva, sinus, úlcera de Marjolin (degeneração maligna crônica)

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos, imobilizado por ____; lesão por pressão em ____ (sacro/isquio/trocâter/calcâneo); grau (NPUAP) ____.
- Braden ____; sinais de infecção/osteomielite ____; Hb ____, albumina ____ (otimização).
- Conduta: mudança de decúbito + alívio de pressão, curativo ____ (AGE/papaína); nutrição.
- Encaminhamento à cirurgia plástica/geral se grau III-IV; ortopedia se suspeita de osteomielite.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a principal medida no manejo da lesão por pressão?

- A) Antibiótico profilático
- B) Prevenção, com mudança regular de decúbito e alívio de pressão
- C) Cirurgia precoce em todos
- D) Restrição hídrica
- E) Repouso absoluto sem mudança de posição

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Lesão por pressão grau I (NPUAP) caracteriza-se por:

- A) Exposição de osso
- B) Epiderme intacta com eritema fixo (que não embranquece)
- C) Perda total da pele com subcutâneo exposto
- D) Escara cobrindo o leito
- E) Necrose muscular

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual escala é usada para avaliar o risco de lesão por pressão?

- A) Escala de Glasgow
- B) Escala de Braden
- C) Escala de Eckardt
- D) Classificação de Hinchey
- E) Escala de Zargar

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quais lesões por pressão geralmente requerem tratamento CIRÚRGICO?

- A) Graus I e II
- B) Graus III e IV (desbridamento + retalho)
- C) Apenas grau I
- D) Nenhuma
- E) Somente lesões em pele íntegra

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual complicação crônica da lesão por pressão corresponde à degeneração maligna?

- A) Úlcera de Cameron
- B) Úlcera de Marjolin
- C) Úlcera de Curling
- D) Úlcera de Cushing
- E) Úlcera péptica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A prevenção é o principal: mudança regular de decúbito e dispositivos de alívio de pressão, associadas à avaliação de risco (Braden), cuidados com a pele e nutrição.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A lesão por pressão grau I (NPUAP) tem epiderme intacta com eritema fixo que não embranquece à digitopressão.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A escala de Braden avalia o risco de lesão por pressão (percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção/cisalhamento).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

As lesões graus III e IV costumam exigir tratamento cirúrgico (desbridamento, excisão de espículas ósseas e cobertura com retalhos), enquanto graus I-II são manejados clinicamente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A úlcera de Marjolin é a degeneração maligna (carcinoma) que pode surgir em feridas crônicas, incluindo lesões por pressão de longa evolução.

SM24
Suporte ao Plantão Médico